

الحقن تحت الجلد

الأهداف : (purpose)

١. إعطاء الأدوية التي لا يمكن أن تؤخذ بالطرق الأخرى أو يمكن أن تعطل بالأنزيمات الهضمية
٢. لضمان الامتصاص والتأثير الأكثر سرعة من الطريق الفموي

الأدوات : (equipment)

١. عربة الدواء
٢. صينية
٣. ملف المريض وسجل الأدوية
٤. زجاجة أو أمبولة الدواء
٥. مبرد (إذا الأمبول لم يחדش)
٦. قطعة شاش صغيرة الحجم
٧. قطن و كحول
٨. إبرة ومحقنة من الحجم المناسب
٩. صندوق السلامة
١٠. وعاء كلوي عدد ٢
١١. بطاقة الدواء

الإجراء : (procedure)

م	الخطوات	التبرير	S تم	الم يتم
أ- تحضير الدواء				
١-	تأكد من تعليمات الطبيب من ملف المريض وقارنها مع سجل الأدوية وحضر بطاقة الدواء	تضمن إعطاء الدواء الصحيح والجرعة الصحيحة.		
٢-	اغسل اليدين	لمنع انتقال العدوى		
٣-	اجمع الأدوات	لتوفير الوقت وزيادة الكفاءة		
٤-	اختر الأمبول /الزجاجة الصحيحة (اقرأ اللاصقة أول مرة) ونقارن مع بطاقة الأدوية ودقق : ١- اسم المريض ٢- رقم السرير	ضمان الدواء الصحيح للمريض الصحيح		

			٣- جرعة الدواء ، التكرار ، طريق الإعطاء ٤- تاريخ ووقت البدء والانتهاء .	
٥-		تحافظ على السلامة	دقق تاريخ انتهاء الصلاحية وأي تغيرات في اللون و القوام	
٦-		تضمن إعطاء الجرعة الصحيحة	احسب الجرعة وأملأ الدواء (اقرأ اللاصقة مرة ثانية)	
٧-		تعطي الجرعة الدقيقة	تخلص من الزجاجاة /الأمبول بشكل ملائم. (اقرأ اللاصقة للمرة الثالثة)	
ب- تحضير المريض				
٨-			أحضر صينية الدواء إلى جانب المريض	
٩-		تضمن السلامة	حدد المريض بتدقيق شريط التعريف والسؤال عن اسم المريض . قارن مع بطاقة الدواء	
١٠-		لتقليل قلق المريض و كسب تعاونه	اشرح الإجراء للمريض	
١١-		تحافظ على الخصوصية	أسدل الستائر أو أغلق الباب	
١٢-		موضع الحقن يجب أن يكون خال من حالات الغير طبيعية التي قد تتداخل مع امتصاص الدواء . مضادات التخثر قد تسبب نزف وكدمة موضعية عندما تحقن داخل المناطق مثل الذراعان والساقان ، التي تشترك في الفعالية العضلية	اختر موضع الحقن (الموضع الذي لم يستعمل بشكل متكرر). قِيم سطح الجلد بالنسبة للكدمات، التهاب، أو وذمة. عند إعطاء الهيبارين تحت الجلد اختر مواضع الحقن البطني .	
١٣-		التناوب على موضع الحقن يمنع التندب تحت الجلد وفرط النمو الشحمي (زيادة النمو في النسيج الشحمي (اللذان يتداخلان مع امتصاص الدواء .	في حالة الحقن المتكررة بشكل يومي (الأنسولين) تناوب على موضع الحقن يومياً .	
١٤-		الموضع الذي يُخَفَضُ الإجهاد على العضلة يقلل إزعاج (ألم بسيط) الحقن.	ساعد المريض ليأخذ وضعية ملائمة لاختيار : "الوجه الخارجي للذراع العلوية " : ذراع المريض يجب أن تكون مسترخية وإلى جانب الجسم "الناحية الفخذية الأمامية " : المريض قد يجلس أو يستلقي مع ساق مسترخية. "الظهر العلوي " : المريض قد يكون منبطحاً أو مستلقياً على الجانب . "البطن " : وضعية الاستلقاء الظهرى أو نصف الجلوس	
ج- إعطاء الدواء				
١٥-		يزيل العمل الميكانيكي للمسحة الإفرازات التي تحتوي الكائنات الحية الدقيقة .	نظف الموقع بمسحة كحول بحركة دائرية ثابتة .	

١٦-	أزل الغطاء أو غلاف الإبرة من الإبرة بسحبها بشكل مستقيم.	تمنع التلوث وتُجنب تداخل المحور	
١٧-	استعمل اليد غير المسيطرة لتوتر /تقرص الجلد (طبقاً لكتلة جسم المريض)	لاظهار المنطقة بشكل جيد .	
١٨-	أمسك الحقنة بين الإبهام والسبابة لليد المسيطرة وأدخل الإبرة بزاوية (٤٥-٦٠ درجة لكل أماكن الحقن ما عدا البطن ٩٠ درجة) للمريض البدين، اقرص الجلد في الموضع واحقن الإبرة تحت طية النسيج	تضمن وصول الدواء للأنسجة تحت الجلد . المرضى البدينين عندهم طبقة دهنية من النسيج فوق الطبقة تحت الجلد	
١٩-	بعد أن تدخل الإبرة الموضع التقط النهاية السفلى لاسطوانة الحقنة باليد غير المسيطرة . حرك باليد المسيطرة نهاية المكبس . تجنب تحريك الحقنة .	يساعد على تثبيت الحقنة ويمنع سحبها للخلف.	
٢٠-	اسحب المدح ببطء للخلف. إذا ظهر الدم في الحقنة انزع الإبرة ،تخلص من الدواء و الحقنة بشكل صحيح وأعد تحضير الإجراء . - إذا لم يظهر الدم ، احقن الدواء ببطء . ملاحظة: بعض السياسات المؤسسية توصي بعدم سحب حقن الهيبارين تحت الجلد	سحب الدم لداخل الحقنة يشير إلى التوضع الوريدي للإبرة . الأدوية تحت الجلد ليست للاستعمال الوريدي . الحقن ببطء يُخفّض رض النسيج والألم . السحب عند إعطاء الهيبارين أو أي مضاد تخثر من المحتمل أن يُتلف النسيج المحيط ويمكن أن يُسبب النزف بالإضافة إلى الكُدم .	
٢١-	اسحب الإبرة بسرعة بينما تضع قطعة قطن جافة بلطف أعلى أو فوق موضع الحقن .	دعم الأنسجة حول موضع الحقن يقلل الانزعاج أثناء انسحاب الإبرة . يسمح للدواء للانتشار بانتظام .	
٢٢-	دلك الجلد بشكل خفيف . (إذا أعطي الهيبارين أو الأنسولين ،اضغط ببساطة قطعة القطن للموضع لمدة بضع ثواني ولا تدلك الجلد) .	التدليك الشديد يمكن أن يسبب النزف والكدمات (رضوض) ويعجل امتصاص الدواء .	
٢٣-	تخلص من الإبرة مفتوحة الغطاء في صندوق السلامة .	تمنع الأذية للمرضى وموظفي الرعاية الصحية .	
٢٤-	أعد الأدوات . واغسل اليدين	تُخفض انتقال الكائنات الدقيقة .	
٢٥-	وثق في ملف المريض و سجل الأدوية ودقتر ملاحظات الممرض: -اسم الدواء ،الجرعة ، وقت الإعطاء، طريق الإعطاء، مكان الحقن ،استجابة المريض ؛اسم الممرض وتوقيعه	التوثيق في الوقت المناسب يمنع أخطاء الإعطاء مستقبلاً.	
٢٦-	قوم بتأثير الدواء بعد ٣٠ دقيقة لكل التأثيرات المرغوبة أو الآثار الجانبية	لمراقبة استجابة المريض للمعالجة	

*S:satisfactory- U:unsatisfactory

ملاحظات المَدْرَس: يؤدي الطالب في مختبر المهارات أوعلى المريض أوضمن المجتمع . سجل عدد المحاولات التي قام بها الطالب قبل الوصول إلى انجاز جيد للمهارة.

اسم وتوقيع المَدْرَس: ----- التاريخ: -----